EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	: HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	: 81663
SERVICIO	: MEDICINA HSC		
FECHA	: 2024-04-01 09:40:00		

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: EDMUNDO CONSTANTINO MANRIQUEZ ZAMBRANO			RUN	: 6.730.373-3
F.Nac	: 29-01-1951	Edad	: 73 AÑOS, 2 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: BULI ESTACION ***PREV.21.3.2020**			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: BLOQUEADO - INDEPENDIENTE	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-03-31	Fecha Egreso	: 2024-04-01 09:40:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DERIVACIÓN A OTROS CENTROS	Derivación	: TRASLADO OTRO HOSPITAL

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) ITU en tratamiento
2) Ca prostatico en cuidados paliativos
3) IC
4) HTA
5) Caso social (mala red de apoyo)

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec descritos, consulta el 29/03 por cuadro de 20 dias de evoluciond e CEG, constipacion, sin expulsion de gases al interrogatorio dirigido.
Examen de lab al ingreso -> crea 1; PCR 186; Na/K/Cl 128/3.9/98; Hb 8,6; Gb 10,8; plaq 337000; orina nitritos (+)
Placa de abdomen simple se evidencia signo de grano de cafe, se decide complementar estudio con TAC
TAC de abdomen y pelvis -> Derrame pleural moderado bilateral, atelectasias segmentarias bibasales, leve hidronefrosis bilateral, quistes simples en ambos riñones, leve dilatacion de aorta abdominal infrarrenal, ateromatosis aortoiliaca difusa, lesiones oseas escleroticas en esqueleto oseo con compromiso difuso de hueso iliaco y sacro
En vista de paciente sociosanitario, se decide ingreso para evaluacion
Durante estadia estable, sin dolor, se procede a iniico de terapia ATB para cobertura de foco urinario, sin necesidad de contencion fisica (pero a la inspeccion con presencia de contencion???); con buena tolerancia oral, sin episodios de nauseas y/o vomitos, diuresis (+), no cuantificada), deposiciones (-)

Examenes de lab 01/04 -> crea 1,2; glicemia 87; PCR 153,3 (prev 188,6), uremia 71; Na/K/Cl 133/3.4/102; proca 0,21
URC 30/03 polimicrobiano

Ex fisico -> Vigil, CLOTE; mucosas rosadas, algod eshidratdas, llene capilar < 2 segs

Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
ABdomen BDI, RHA (+´), sin signos de irritacion peritoneal, en sonda foley se evidencia restos de hematuria
Extremidades edema EEII ++/+++ bilateral, mayor en region inferior

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3)Infeccioso/Urinario: Con paramatros inflamatorios en descenso, resultado de URC polimicrobiano, se continuara con terapia ATB establecida, se solicitara nuevo URC apra ajuste psoterior de terapia
4) Cardiovascular: COn signos de edema actual al examen fisico, se iniciara restriccion hidrica, sumado a BH, se agregara terapia depletiva cautelosa, control con perfil renal dentro de 24 hrs
5) Social: Paciente sin red de apoyo actual, se procedera a crsar IC a asistente social, se continuara tratamiento de paciente en hospital copmunitario

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo semisentado 30°
2. Regimen hiposodico a tolerancia
3. Restriccion hidrica 800 cc al dia
4. Ceftriaxona 2 gr al dia EV
5. Clexane 40 mg al dia SC
6. Omeprazol 20 mg al dia VO
7. Quetiapina 25 mg al dia VO
8. Furosemida 20 mg 1-0-1/2 VO
9. Lactulosa 20 cc c/8hrs VO
10. Metoclopramida 10 mg c/8hrs VO
11. Celecobix 200 mg al dia VO
12. Elcad D un comp al dia VO
13. Transtec (parche) 35 mcg c/72 hrs transcutaneo
14. Examenes de lab 03/04
15. CSV c/8hrs
16. Traslado a hospital comunitario
17. Se solciita evaluacion por asistente social

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO